

	PROTOCOLO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS CRÍTICOS	Código:	AOC 1.2
		Fecha:	Febrero de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Febrero de 2028
		Página:	Página 1 de 26

PROTOCOLO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS CRÍTICOS DE EXÁMENES DE IMAGENOLOGÍA, LABORATORIO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA (PAP).

**Unidad de Calidad y Seguridad del Usuario, CESFAM Dr.
Orlando Leyton A., Peralillo**

Elaborado por: T.M Pía Gálvez Leyton Mat. Nataly Cortés Farfal Psic. Yorka Acuña O	Revisado por: EU María José Solís L	Aprobado por: Dr. Cristian Cárdenas Espinoza
Unidad: Laboratorio, Programa de la Mujer, Resolutividad	Unidad: Área Técnica Unidad de Calidad.	Unidad: Director CESFAM Peralillo.
Fecha: 1 de Febrero 2024	Fecha: 23 de Febrero 2024	Fecha: 29 de Febrero 2024
Firma:   	Firma: 	Firma: 

	PROTOCOLO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS CRÍTICOS	Código:	AOC 1.2
		Fecha:	Febrero de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Febrero de 2028
		Página:	Página 2 de 26

I. INTRODUCCIÓN.

La atención en salud requiere en múltiples ocasiones de exámenes complementarios que permitan confirmar una serie de sospechas de índole diagnóstico. Ante resultados alterados críticos, se requiere un flujo de trabajo conocido que permita dar prioridad en la notificación y atención del usuario/a logrando una intervención expedita ante situaciones de riesgo. El presente documento establece los procesos necesarios a nivel institucional para asegurar la oportunidad de la atención ante estas situaciones.

II. OBJETIVOS.

a. OBJETIVO GENERAL

Asegurar la notificación oportuna de situaciones de riesgo detectadas a través de exámenes diagnósticos en las áreas de: Laboratorio clínico, anatomía patológica (citología- examen PAP) e imagenología.

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Describir las situaciones o resultados críticos que requieren notificación, su procedimiento y responsable de la aplicación.
- Definir indicador, umbral de cumplimiento y evaluación periódica de proceso de notificación de valor crítico en laboratorio, anatomía patológica (toma de PAP) e imágenes diagnósticas.
- Implementar sistema de registro de notificación realizada a nivel institucional.

	PROTOCOLO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS CRÍTICOS	Código:	AOC 1.2
		Fecha:	Febrero de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Febrero de 2028
		Página:	Página 3 de 26

III. ALCANCE

- Todos los profesionales gestores de demanda, clínicos, TENS y equipo administrativo que interviene en este sistema tanto en CESFAM como Postas de Salud Rurales.

IV. DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES.

Según desarrollo y anexo del presente protocolo.

V. DEFINICIONES

- **Resultado Crítico:** Resultado de un análisis que requiere acción médica inmediata por poner en riesgo la vida del usuario/a.
- **Notificación:** Es el acto de informar al Profesional tratante y al usuario/a, que el resultado de su examen es considerado inesperado y que necesita manejo inmediato o precoz.
- **Notificación efectiva:** Se considera notificación de resultado crítico efectivamente realizada cuando corroboramos que el/la profesional encargado de la atención y/o el/la paciente ha retirado o recibido su examen con informe respectivo y se ha dejado constancia en ficha clínica y/o planilla de registro de notificación de resultados críticos.
- **SIL:** Sistema Informático de Laboratorio.

	PROTOCOLO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS CRÍTICOS	Código:	AOC 1.2
		Fecha:	Febrero de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Febrero de 2028
		Página:	Página 4 de 26

VI. DESARROLLO DEL PROCESO.

1. LABORATORIO CLÍNICO.

a. Listado de resultados críticos.

Se define en el siguiente cuadro los resultados que deben notificarse de forma inmediata para exámenes de laboratorio, sus valores críticos y tiempo máximo de notificaciones:

EXAMEN		VALOR CRÍTICO BAJO	VALOR CRÍTICO ALTO	TIEMPO MÁXIMO DE NOTIFICACIÓN DE LABORATORIO A PROFESIONAL/UNIDAD	TIEMPO MÁXIMO DE ATENCIÓN EFECTIVA
HEMATOLOGÍA	Hematocrito adulto	<20%	>60%	8 horas	5 días hábiles
	Hemoglobina adulto	≤ 7g/dl	>20 g/dl	8 horas	5 días hábiles
	Recuento Leucocitos adultos	<2.000/uL	>50.000/uL	8 horas	5 días hábiles
	Recuento de plaquetas	<50.000/uL	>900.000/uL	8 horas	5 días hábiles
BIOQUÍMICA	Ácido Úrico en embarazadas	—	>8.0 mg/dl	8 horas	5 días hábiles
	Ácido Úrico	—	>13.0 mg/dl	8 horas	5 días hábiles
	Cloro	<75 mEq/L	>125 mEq/L	8 horas	5 días hábiles
	Creatinina	—	≥ 4.0 mg/dl	8 horas	5 días hábiles
	Glucosa adultos	≤50 mg/dl	> 500 mg/dl	8 horas	5 días hábiles

	PROTOCOLO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS CRÍTICOS	Código:	AOC 1.2
		Fecha:	Febrero de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Febrero de 2028
		Página:	Página 5 de 26

	Urea	—	>100 mg/dl	8 horas	5 días hábiles
	Sodio	≤125 mEq/L	≥160 mEq/L	8 horas	5 días hábiles
	Potasio	≤ 3 mEq/L	≥6.0 mEq/L	8 horas	5 días hábiles
	Triglicéridos	—	>1500 mg/dl	8 horas	5 días hábiles
HORMONALES	TSH	—	>100 mUI/L	8 horas	5 días hábiles
MICROBIOLOGÍA	Baciloscopia	—	BAAR +, ++, +++	8 horas	5 días hábiles
	RPR embarazadas	—	Positivo	8 horas	5 días hábiles

En casos de resultados de laboratorio donde Tecnólogo/a médico/a de CESFAM determine un riesgo inminente de la vida, el/la profesional queda autorizado/a para realizar el contacto efectivo con el usuario/a afectado/a en menos de 24 horas.

En el caso de laboratorios externos, estos deberán informar el valor crítico de examen a Tecnólogo/o médica/o de CESFAM, adjuntando con posterioridad exámenes vía correo electrónico en los tiempos definidos en sus protocolos internos vigentes.

A continuación se establecen los procesos internos de notificación en CESFAM Dr. Orlando Leyton A.

Persona que notifica resultado crítico	Tecnóloga médica de CESFAM Dr. Orlando Leyton A. o quien le subroge.
Persona a quien se da el aviso.	Profesional que realizó la solicitud de examen o en su defecto TENS coordinador de la unidad.
Forma que se da la información al personal	El Tecnólogo/a Médico/a de la sección respectiva o quien le subroge que obtuvo el resultado crítico,

	PROTOCOLO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS CRÍTICOS	Código:	AOC 1.2
		Fecha:	Febrero de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Febrero de 2028
		Página:	Página 6 de 26

clínico.	comunica inmediatamente el informe vía telefónica y/o correo electrónico al profesional clínico o TENS del Servicio o Unidad solicitante.
Contacto con el usuario/a	Profesional que realizó la solicitud de examen o en su defecto /TENS coordinador de la unidad.
Forma que se realiza el contacto con el usuario/a	Vía telefónica de preferencia.
Qué se hace al no conseguir contacto efectivo	- Se deben realizar 3 llamados telefónicos en 3 días distintos. - En caso de no obtener respuesta se procederá a realizar visita domiciliaria de rescate.
Procesos a realizar en contacto efectivo	Profesional clínico/TENS podrá solicitar hora de atención presencial en SOME con médico de morbilidad para revisar exámenes o bien el profesional a través de llamado telefónico podrá establecer indicaciones al usuario/as afectado según patología de base, sobre todo en el caso de personas dializadas. En caso necesario médico de morbilidad realizará interconsulta a nivel secundario según complejidad.
Registros a utilizar	Registro de notificación de resultado crítico (anexo 1) Exámenes de usuario (LIS), en formato digital en custodia de encargado de calidad. Registro ficha clínica.

	PROTOCOLO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS CRÍTICOS	Código:	AOC 1.2
		Fecha:	Febrero de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Febrero de 2028
		Página:	Página 7 de 26

Puntos de verificación	Registro planilla digital google drive.
------------------------	---

Observación: Antes de notificar al personal clínico la tecnóloga médica deberá verificar el desarrollo de la técnica: condiciones de la muestra (muestra coagulada, lipémica, mal tomada), control de calidad.

A continuación se establecen los procesos internos de notificación Postas de Salud Rurales:

Persona que notifica resultado crítico	Tecnóloga médica de CESFAM Dr. Orlando Leyton A. o quien le subrogue
Persona a quien se da el aviso.	TENS de postas.
Forma que se da la información al personal clínico.	El Tecnólogo/a Médico/a o quien le subrogue de la sección respectiva que obtuvo el valor crítico, realiza llamado telefónico a TENS de Postas y/o enviar correo electrónico al profesional solicitante de examen y/o al correo electrónico de posta.
Contacto con el usuario/a	TENS de posta realiza contacto telefónico con usuario.
Forma que se realiza el contacto con el usuario/a	Vía telefónica de preferencia.
Qué se hace al no conseguir contacto efectivo	- Se deben realizar 3 llamados telefónicos en 3 días distintos. - En caso de no obtener respuesta se procederá a realizar visita domiciliaria de rescate.

	PROTOCOLO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS CRÍTICOS	Código:	AOC 1.2
		Fecha:	Febrero de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Febrero de 2028
		Página:	Página 8 de 26

Procesos a realizar en contacto efectivo	TENS de posta gestiona dación de hora al usuario/a en morbilidad médica en caso de necesitar atención presencial. En caso necesario médico de morbilidad realizará interconsulta a nivel secundario según complejidad. También el profesional podrá dar las indicaciones al usuario/a vía telefónica según el caso, en especial en caso de dializados.
Registros a utilizar	Registro de notificación de resultado crítico (anexo 1) Exámenes de usuario (LIS) en formato digital en custodia de encargado de calidad. Registro ficha clínica.
Puntos de verificación	Registro planilla digital google drive.

Observación: Antes de notificar al personal clínico la tecnóloga médica deberá verificar el desarrollo de la técnica: condiciones de la muestra (muestra coagulada, lipémica, mal tomada), control de calidad.

2. EXAMEN PAP.

a. Resultados críticos.

Se define en el siguiente cuadro los resultados que deben notificarse de forma inmediata para exámenes de PAP con sus valores críticos. El plazo máximo de consulta efectiva con matrona será de 7 días hábiles desde que se recepciona el resultado crítico:

	PROTOCOLO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS CRÍTICOS	Código:	AOC 1.2
		Fecha:	Febrero de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Febrero de 2028
		Página:	Página 9 de 26

PAP	RESULTADOS
A	Probable lesión intraepitelial de bajo grado (NIE II)
A1	Cambios celulares asociados a infección por VPH con indicación de derivar (T)
B	Probable lesión intraepitelial de alto grado (NIE II)
C	Probable lesión intraepitelial de alto grado (NIE III) o Ca in Situ
D	Probable adenocarcinoma.
D 0	Probable adenocarcinoma endocervical in situ
D 1	Probable adenocarcinoma de origen endocervical
D 2	Probable adenocarcinoma de origen endometrial
D 3	Probable carcinoma adenoescamoso
E	Probable carcinoma escamoso
E 1	Probable carcinoma indiferenciado
E 2	Probable tumos maligno extracervical
H 2	Células escamosas atípicas, sugerentes de LIE alto grado o Ca. invasor
H 3	Células glandulares atípicas, sugerentes de origen endocervical o endometrial reactivas.
H 4	Células glandulares atípicas, sugerentes de Neoplasia Maligna de origen endocervical, endometrial o no definido

A continuación se establecen los procesos internos de notificación en CESFAM Dr. Orlando Leyton A y Postas de Salud Rurales.

Persona que notifica resultado crítico	Resultado crítico es enviado por unidad de Patología dependiente de DSS O'Higgins vía planilla semanal.
Persona que revisa la planilla con resultados.	Matrona programa de la mujer o quien le subrogue es quien revisa la planilla e inicia el proceso de comunicación efectiva.
Contacto con el usuario/a	La Matrona programa de la mujer o quien le subrogue se contacta con usuaria.
Forma que se realiza el	Vía telefónica de preferencia.

	PROTOCOLO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS CRÍTICOS	Código:	AOC 1.2
		Fecha:	Febrero de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Febrero de 2028
		Página:	Página 10 de 26

contacto con el usuario/a	
Qué se hace al no conseguir contacto efectivo	- Se deben realizar 3 llamados telefónicos en 3 días distintos. - En caso de no obtener respuesta se procederá a realizar visita domiciliaria de rescate.
Procesos a realizar en el contacto efectivo	Matrona explica vía telefónica a usuaria implicancias de diagnóstico e informa que se generará una interconsulta a nivel secundario según complejidad.
Registros a utilizar	Registro de notificación de resultado crítico (anexo 1) Planilla con nómina de PAP (archivado en box TENS Matrona de forma anual, que posteriormente es eliminado), Registro ficha clínica.
Puntos de verificación	Registro planilla digital google drive. Planilla con nómina de PAP: Carpeta en box TENS de Matrona.

3. IMÁGENES DIAGNÓSTICAS.

En la actualidad el Departamento de Salud de Peralillo recibe convenios con recursos económicos para la adquisición de imágenes diagnósticas desde la Dirección de Servicio de Salud O'Higgins, las cuales se licitan todos los años. La canasta incluye: Radiografía de pelvis para niños 3 a 6 meses de edad, radiografía de tórax, ecotomografía abdominal, mamografías-magnificaciones-ecomamarias.

	PROTOCOLO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS CRÍTICOS	Código:	AOC 1.2
		Fecha:	Febrero de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Febrero de 2028
		Página:	Página 11 de 26

Dentro de las bases de licitación deberá existir un punto que indique la forma de trabajo en caso de valores críticos de exámenes, donde la empresa deberá enviar el resultado en un máximo de 24 horas desde que se obtuvo el resultado del examen a mail institucional propio para este fin: valorcritico@muniperalillo.cl.

Tal mail será de uso exclusivo de Gestor de valor crítico o quien le subroge.

Se definen en primer lugar los valores críticos para estos exámenes con los tiempos de respuesta:

Tipo de examen	Resultado notificación diferida	Tiempo de atención efectiva.
Radiografía de pelvis, tórax, eco tomografía abdominal, Mamografías, eco mamaria y magnificaciones.	Signos de neoplasia.	Hasta 7 días hábiles una vez recepcionado el resultado vía mail.
	Signos de progresión de neoplasia conocida.	
	Radiografía con ángulo acetabular igual o mayor a 30° (Displasia de caderas).	
	Cuerpo extraño quirúrgico.	
	BIRARS 4 o signos sospechosos de neoplasia mamaria.	
	Signos de litiasis u obstrucciones de la vía biliar.	

	PROTOCOLO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS CRÍTICOS	Código:	AOC 1.2
		Fecha:	Febrero de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Febrero de 2028
		Página:	Página 12 de 26

A continuación se establecen los procesos internos de notificación en CESFAM **Dr. Orlando Leyton A para radiografía de pelvis:**

Persona que notifica resultado crítico	Centro clínico que realiza la prestación envía a correo electrónico la alerta de valor crítico. Gestor de valor crítico de CESFAM titular o quien le subrogue revisa correo, realiza la primera parte de registro de notificación resultado crítico (Anexo 1).
Persona a quien se da el aviso.	Gestor de valor crítico titular o quien le subrogue da aviso a Enfermera Encargada de Programa Salud Infantil o quien le subrogue.
Forma que se da la información al personal clínico.	Vía correo electrónico Gestor de valor crítico da aviso a Enfermera Encargada de Programa Salud Infantil o quien le subrogue.
Contacto con el usuario/a	Enfermera Encargada Programa Salud Infantil o quien subrogue establece contacto con tutores del menor.
Forma que se realiza el contacto con el usuario/a	Vía telefónica de preferencia.
Qué se hace al no conseguir contacto efectivo	- Se deben realizar 3 llamados telefónicos en 3 días distintos. - En caso de no obtener respuesta se procederá a realizar visita domiciliaria de rescate.
Procesos a realizar en contacto efectivo	Enfermera Encargada Programa Salud Infantil gestiona hora de atención con médico de morbilidad.

	PROTOCOLO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS CRÍTICOS	Código:	AOC 1.2
		Fecha:	Febrero de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Febrero de 2028
		Página:	Página 13 de 26

Registros a utilizar	Registro de notificación de resultado crítico (anexo 1) Resultados de examen alterado en digital custodiado por Encargado de Calidad. Registro ficha clínica con evolución de atención médica.
Puntos de verificación	Registro planilla digital google drive.

A continuación se establecen los procesos internos de notificación en **Postas de Salud Rurales para radiografía de pelvis:**

Persona que notifica resultado crítico	Centro clínico que realiza la prestación envía a correo electrónico la alerta de valor crítico. Gestor de valor crítico de CESFAM titular o quien le subrogue revisa correo, realiza la primera parte registro de notificación resultado crítico (Anexo 1).
Persona a quien se da el aviso.	Gestor de valor crítico titular o quien le subrogue da aviso a Enfermera Encargada de Programa Salud Infantil o quien le subrogue.
Forma que se da la información al personal clínico.	Vía correo electrónico Gestor de valor crítico da aviso a Enfermera Encargada de Programa Salud Infantil o quien le subrogue. Enfermera da aviso a TENS de Postas vía telefónica con envío de resultados al correo electrónico de cada posta.
Contacto con el usuario/a	TENS de postas establece contacto con tutores del menor.

	PROTOCOLO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS CRÍTICOS	Código:	AOC 1.2
		Fecha:	Febrero de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Febrero de 2028
		Página:	Página 14 de 26

Forma que se realiza el contacto con el usuario/a	Vía telefónica de preferencia.
Qué se hace al no conseguir contacto efectivo	- Se deben realizar 3 llamados telefónicos en 3 días distintos. - En caso de no obtener respuesta se procederá a realizar visita domiciliaria de rescate.
Procesos a realizar en contacto efectivo	TENS de postas gestiona hora de atención con médico de morbilidad. Médico de morbilidad realiza en fecha agendada la evaluación y derivación respectiva nivel secundario.
Registros a utilizar	Registro de notificación de resultado crítico (anexo 1) Registro ficha clínica.
Puntos de verificación	Registro planilla digital google drive.

A continuación se establecen los procesos internos de notificación en CESFAM Dr. Orlando Leyton A para **radiografía de tórax:**

Persona que notifica resultado crítico.	Centro clínico que realiza la prestación envía a correo electrónico la alerta de valor crítico. Gestor de valor crítico de CESFAM o quien le subrogue revisa correo, realiza la primera parte de registro notificación de resultado crítico (Anexo 1).
Persona a quien se da el aviso.	Gestor de valor crítico o quien le subrogue toma el caso para gestionarlo.
Contacto con el usuario/a	Gestor de valor crítico o quien le subrogue solicita a

	PROTOCOLO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS CRÍTICOS	Código:	AOC 1.2
		Fecha:	Febrero de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Febrero de 2028
		Página:	Página 15 de 26

	Jefa de SOME o a quien le subrogue vía correo electrónico contactarse con usuario/a para indicar necesidad de atención inmediata.
Forma que se realiza el contacto con el usuario/a	Vía telefónica de preferencia.
Qué se hace al no conseguir contacto efectivo	- Se deben realizar 3 llamados telefónicos en 3 días distintos. - En caso de no obtener respuesta se procederá a realizar visita domiciliaria de rescate.
Procesos a realizar en contacto efectivo	SOME otorga hora de atención con médico de morbilidad. Si es posible, priorizar atención con médicos de programa respiratorio. Profesional realiza derivación a nivel secundario.
Registros a utilizar	Registro de notificación de resultado crítico (anexo 1) Registro ficha clínica.
Puntos de verificación	Registro planilla digital google drive.

A continuación se establecen los procesos internos de notificación en Postas de Salud Rurales para **radiografía de tórax:**

Persona que notifica resultado crítico	Gestor de valor crítico o quien le subrogue recibe el valor crítico vía correo electrónico del centro de imagen.
Persona a quien se da el aviso.	Gestor de valor crítico se contacta vía telefónica con TENS de posta de salud rural solicitando contacto

	PROTOCOLO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS CRÍTICOS	Código:	AOC 1.2
		Fecha:	Febrero de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Febrero de 2028
		Página:	Página 16 de 26

	inmediato con el usuario afectado. Gestor de valor crítico envía correo electrónico de respaldo a mail de postas.
Contacto con el usuario/a	TENS de postas realiza contacto con usuario/a.
Forma que se realiza el contacto con el usuario/a	Vía telefónica de preferencia.
Qué se hace al no conseguir contacto efectivo	- Se deben realizar 3 llamados telefónicos en 3 días distintos. - En caso de no obtener respuesta se procederá a realizar visita domiciliaria de rescate.
Procesos a realizar en contacto efectivo	TENS de postas otorga hora de atención con médico de morbilidad. Profesional realiza derivación a nivel secundario.
Registros a utilizar	Registro de notificación de resultado crítico (anexo 1) Registro ficha clínica.
Puntos de verificación	Registro planilla digital google drive.

A continuación se establecen los procesos internos de notificación en CESFAM **Dr. Orlando Leyton A para ecotomografía abdominal:**

Persona que notifica resultado crítico	Centro clínico que realiza la prestación envía a correo electrónico la alerta de valor crítico. Gestor de valor crítico de CESFAM o quien le subroga revisa correo, realiza la primera parte de registro de notificación de resultado crítico (Anexo 1).
--	--

	PROTOCOLO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS CRÍTICOS	Código:	AOC 1.2
		Fecha:	Febrero de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Febrero de 2028
		Página:	Página 17 de 26

Persona a quien se da el aviso.	Gestor de valor crítico avisa a TANS de OIRS vía correo electrónico (ccontreras@muniperalillo.cl). En ausencia de esta persona se avisa a Jefa SOME. (beatrizsanmartin@muniperalillo.cl)
Contacto con el usuario/a	TANS de OIRS o quien le subrogue se contacta con usuario/a para indicar necesidad de atención inmediata. Se gestiona en este tiempo la hora de atención en morbilidad médica.
Forma que se realiza el contacto con el usuario/a	Vía telefónica de preferencia.
Qué se hace al no conseguir contacto efectivo	- Se deben realizar 3 llamados telefónicos en 3 días distintos. - En caso de no obtener respuesta se procederá a realizar visita domiciliaria de rescate.
Procesos a realizar en contacto efectivo	TANS OIRS otorga hora de atención con médico de morbilidad. Profesional realiza derivación a nivel secundario.
Registros a utilizar	Registro de notificación de resultado crítico (anexo 1) Registro ficha clínica de atención médica.
Puntos de verificación	Registro planilla digital google drive.

	PROTOCOLO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS CRÍTICOS	Código:	AOC 1.2
		Fecha:	Febrero de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Febrero de 2028
		Página:	Página 18 de 26

A continuación se establecen los procesos internos de notificación en Postas de Salud Rurales para ecotomografía abdominal:

Persona que notifica resultado crítico	Gestor de valor crítico CESFAM o quien subrogue recibe resultado crítico del centro de imagen.
Persona a quien se da el aviso.	Gestor de valor crítico realiza contacto telefónico con TENS de Postas para indicar necesidad de atención inmediata. Envía mail a Postas como respaldo.
Contacto con el usuario/a	TENS de Postas realiza contacto con usuario/a.
Forma que se realiza el contacto con el usuario/a	Vía telefónica de preferencia.
Qué se hace al no conseguir contacto efectivo	- Se deben realizar 3 llamados telefónicos en 3 días distintos. - En caso de no obtener respuesta se procederá a realizar visita domiciliaria de rescate.
Procesos a realizar en contacto efectivo	TENS de postas otorga hora de atención con médico de morbilidad. Profesional realiza derivación a nivel secundario.
Registros a utilizar	Registro de notificación de resultado crítico (anexo 1) Registro ficha clínica.
Puntos de verificación	Registro planilla digital google drive.

	PROTOCOLO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS CRÍTICOS	Código:	AOC 1.2
		Fecha:	Febrero de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Febrero de 2028
		Página:	Página 19 de 26

A continuación se establecen los procesos internos de notificación en CESFAM Dr.

Orlando Leyton A para **mamografías-magnificaciones y ecomamarias:**

Persona que notifica resultado crítico	Centro clínico que realiza la prestación envía a correo electrónico la alerta de valor crítico. Gestor de valor crítico de CESFAM o quien subrogue revisa correo, realiza la primera parte de registro de notificación de valor crítico (Anexo 1).
Persona a quien se da el aviso.	Gestor de valor crítico se contacta de forma presencial o por teléfono con Matrona de sector. Envía mail de respaldo.
Contacto con el usuario/a	Matrona se contacta con usuario/a para indicar necesidad de atención inmediata.
Forma que se realiza el contacto con el usuario/a	Vía telefónica de preferencia.
Qué se hace al no conseguir contacto efectivo	- Se deben realizar 3 llamados telefónicos en 3 días distintos. - En caso de no obtener respuesta se procederá a realizar visita domiciliaria de rescate.
Procesos a realizar en contacto efectivo	Matrona de sector otorga hora de atención efectiva. En la atención clínica matrona de sector realiza evaluación, define análisis complementarios según sugerencias de radiólogo y/o derivación a nivel secundario.
Registros a utilizar	Registro de notificación de resultado crítico (anexo 1)

	PROTOCOLO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS CRÍTICOS	Código:	AOC 1.2
		Fecha:	Febrero de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Febrero de 2028
		Página:	Página 20 de 26

	Tarjetero de mamas. Registro ficha clínica.
Puntos de verificación	Cardex en box de TENS Matrona.

Observación: En el caso que las usuarias vengan con exámenes realizados de forma particular, la matrona que los revise deberá realizar la derivación según se estime el caso, evolucionar en ficha clínica y completar la parte 1 y 2 del registro de notificación resultado crítico (Anexo 1).

A continuación se establecen los procesos internos de notificación Postas de Salud Rurales para **mamografías-magnificaciones y ecomamarias:**

Persona que notifica resultado crítico	Gestor de valor crítico CESFAM o quien le subrogue recibe vía mail resultado valor crítico.
Persona a quien se da el aviso.	Gestor de valor crítico se contacta vía telefónica con TENS de Postas. Envía mail de respaldo a posta de salud rural.
Contacto con el usuario/a	TENS de postas se contacta con usuario/a para indicar necesidad de atención inmediata.
Forma que se realiza el contacto con el usuario/a	Vía telefónica de preferencia.
Qué se hace al no conseguir contacto efectivo	- Se deben realizar 3 llamados telefónicos en 3 días distintos. - En caso de no obtener respuesta se procederá a realizar visita domiciliaria de rescate.
Procesos a realizar en	TENS de posta otorga hora de atención con

	PROTOCOLO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS CRÍTICOS	Código:	AOC 1.2
		Fecha:	Febrero de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Febrero de 2028
		Página:	Página 21 de 26

contacto efectivo	matrona de sector. Profesional realiza derivación a nivel secundario.
Registros a utilizar	Registro de notificación de resultado crítico (anexo 1) Registro ficha clínica.
Puntos de verificación	Registro planilla digital google drive.

Observación: En el caso que las usuarias vengan con exámenes realizados de forma particular, la matrona del sector rural que los revise deberá realizar la derivación según se estime el caso, evolucionar en ficha clínica y completar la parte 1 y 2 del registro de notificación de resultado crítico (Anexo 1).

VIII. INDICADOR Y UMBRAL DE CUMPLIMIENTO.

a) Exámenes de laboratorio.

Nombre del Indicador	Porcentaje de notificación de resultados críticos según protocolo en laboratorio clínico en el trimestre.
Fórmula	$\left(\frac{\text{N}^{\circ} \text{ de resultados críticos de laboratorio clínico notificados de acuerdo a protocolo en el trimestre}}{\text{N}^{\circ} \text{ total de resultados críticos de laboratorio clínico en el trimestre}} \right) \times 100.$
Tipo	Proceso.
Fuente de datos	Sistema Informático de Laboratorio Registro de notificación de resultado(s) crítico(s)
Umbral de cumplimiento	$\geq 75\%$
Metodología de selección de casos	Se incluyen en la evaluación todos los resultados críticos del trimestre.

	PROTOCOLO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS CRÍTICOS	Código:	AOC 1.2
		Fecha:	Febrero de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Febrero de 2028
		Página:	Página 22 de 26

Responsables	Jefe de Laboratorio
Periodicidad	Trimestral

b) Exámenes de PAP:

Nombre del Indicador	Porcentaje de notificación de resultados críticos según protocolo de PAP en el semestre.
Fórmula	$\left(\frac{\text{N}^{\circ} \text{ de resultados críticos de PAP realizados de acuerdo a protocolo en el semestre}}{\text{N}^{\circ} \text{ total de notificaciones de resultados críticos de PAP efectuadas en el semestre}} \right) \times 100.$
Tipo	Proceso.
Fuente de datos	Planilla de resultados PAP Registro de notificación de resultado(s) crítico(s)
Umbral de cumplimiento	$\geq 75\%$
Metodología de selección de casos	Se incluyen en la evaluación todos los resultados críticos del semestre.
Responsables	Matrona encargada programa de la mujer o subrogante.
Periodicidad	Semestral.

c) Exámenes de imagenología: Mamografías:

Nombre del Indicador	Porcentaje de notificación de resultados críticos según protocolo de mamografías en el mes.
Fórmula	$\left(\frac{\text{N}^{\circ} \text{ de resultados críticos de mamografías realizados de}}{\text{N}^{\circ} \text{ total de mamografías efectuadas en el mes}} \right) \times 100.$

	PROTOCOLO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS CRÍTICOS	Código:	AOC 1.2
		Fecha:	Febrero de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Febrero de 2028
		Página:	Página 23 de 26

	acuerdo a protocolo en el mes / N° total de notificaciones de resultados críticos de mamografías efectuadas en el mes) x 100.
Tipo	Proceso.
Fuente de datos	Planilla de resultados mamografía (interno o al prestador) Registro de notificación de resultado(s) crítico(s)
Umbral de cumplimiento	≥ 75%
Metodología de selección de casos	Se incluyen en la evaluación todos los resultados críticos del mes.
Responsables	Encargada programa de la mujer.
Periodicidad	Mensual.

IX. DISTRIBUCION

- Dirección CESFAM Dr. Orlando Leyton A.
- Unidad de Calidad y Seguridad del Usuario.
- Unidad Laboratorio Clínico.
- Profesionales Programa IRA-ERA.
- Servicio Maternal: Matronas y TENS de apoyo.
- Postas de Salud Rurales.
- Jefas de Sector Urbano y Rural.
- Encargada de Programa resolutividad e imágenes diagnósticas.
- Enfermeras, Médicos, OIRS, SOME CESFAM.

X. BIBLIOGRAFÍA.

Instituto De Salud Pública De Chile. Notificación De Valores O Resultados Críticos, Recomendaciones Generales Laboratorio Clínico, Anatomía Patológica

	PROTOCOLO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS CRÍTICOS	Código:	AOC 1.2
		Fecha:	Febrero de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Febrero de 2028
		Página:	Página 24 de 26

E Imagenología”. Santiago, Chile. Junio 2013, Guías Clínicas AUGE Cáncer Cervico Uterino. Noviembre de 2015.

XI. AUTORES

- Matrona Nataly Cortés Farfal, Encargada Programa Cáncer cérvico uterino CESFAM Peralillo.
- T.M Pía Gálvez Leyton, Encargada Laboratorio Clínico CESFAM Peralillo.
- Psic. Yorka Acuña Olmedo, Encargada de Programa Imágenes Diagnósticas.

XII. CONTROL DE CAMBIOS.

Corrección	Fecha	Descripción de la modificación	Publicado en	N° documento

	PROTOCOLO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS CRÍTICOS		Código:	AOC 1.2
			Fecha:	Febrero de 2024
			Versión:	1.0
			Vigencia:	Febrero de 2028
			Página:	Página 25 de 26

XIII. ANEXOS.

Anexo 1:

a. Registro de notificación de resultados críticos PAP e imágenes diagnósticas y responsabilidad de llenado.

Planilla de notificación de resultados críticos PAP e imágenes diagnósticas CESFAM Dr. Orlando Leyton A y Postas de Salud Rurales																
Parte 1. Responsabilidad de llenado del gestor de demanda: Matrona PAP										Parte 2. Responsabilidad de llenado de personal que notifica: TENS- SOME- Matrona				Parte 3. Responsabilidad de llenado Encargado de Calidad		
N°	Año	Nombre usu.	Apellido pa.	Apellido ma.	RUT del usu.	Tipo de examen not.	Diagnóstico del examen	Fecha de recepción de resultado desde centro derivado	Nombre del gestor de demanda que recibe la información	Fecha de notificación al usuario	Tipo de notificación	Nombre y apellido del personal de salud que notifica	Cumple con plazo de notificación	Fecha de atención presencial	Nombre y apellido del profesional que realiza atención presencial	Otras observaciones

La parte 1 es de responsabilidad de Gestor de valor crítico y matrona programa de la mujer o quienes le subroguen.

La parte 2 es responsabilidad del personal que notifica: Matrona programa mujer (PAP), Jefa de SOME CESFAM y TENS Postas (Radiografía de tórax), Enfermera programa salud infantil y TENS Postas (Radiografía de pelvis), TANS OIRS y TENS Postas (ecotomografía abdominal), Matrona sector urbano y TENS Postas (mamografías, ecomamografías, magnificaciones).

La parte 3 es responsabilidad de encargado de calidad o quien le subroque.

b. Registro de notificación de resultados críticos Laboratorio clínico y responsabilidad de llenado.

Planilla de notificación de resultados críticos Unidad Laboratorio CESFAM Dr. Orlando Leyton A y Postas de Salud Rurales																
Parte 1: Responsabilidad de llenado de Tecnólogo médico										Parte 2: Responsabilidad de llenado de personal que notifica: Profesionales TENS de salud				Parte 3: Responsabilidad de llenado Encargado de Calidad		
N°	Fecha de envío	Marcar con que centralidad comunicada	Nombre del usuario	Apellido Paterno	Apellido Materno	RUT del usuario	Servicio clínico al que pertenece el usuario	Nombre del examen con resultado crítico	Nombre de quien recibe la información	Fecha de notificación al usuario	Tipo de notificación	Nombre y apellido del personal de salud que notifica	Cumple con plazo de notificación	Fecha de atención	Nombre y apellido del profesional que realiza atención presencial	Otras observaciones

La parte 1 es responsabilidad de tecnólogo médico de CESFAM Dr. Orlando Leyton A o quien le subroque.

La parte 2 es responsabilidad del profesional que realizó la solicitud de examen o TENS coordinador (Médicos/as que trabajan en unidades cardiovascular, morbilidad,

	PROTOCOLO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS CRÍTICOS	Código:	AOC 1.2
		Fecha:	Febrero de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Febrero de 2028
		Página:	Página 26 de 26

SUR, TENS Cardiovascular, Matronas, TENS Matrona, Odontólogos, Kinesiólogos/as).

La parte 3 es responsabilidad de Encargado de Calidad o quien le subrogue.

ANEXO N°2: CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES DE POSTAS DE SALUD RURAL Y PROFESIONALES.

Profesional / Posta de Salud	CORREO ELECTRÓNICO
POSTA CALLEUQUE	postacalleuque@municipalillo.cl
POSTA LOS CARDOS	postaloscardos@municipalillo.cl
POSTA POBLACIÓN	postapoblacion@municipalillo.cl
E.M.R RINCONADA MOLINEROS	emrrinconadademolineros@municipalillo.cl
ENCARGADO DE CALIDAD	c.cardenas@municipalillo.cl
MAIL VALOR CRÍTICO	valorcritico@municipalillo.cl
PROFESIONALES CESFAM/POSTAS	Consultar según rotación.
GESTOR DE VALOR CRÍTICO	Consultar según orden administrativa